SENTENÇA

Processo: 0836132-54.2024.8.19.0203

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ROSA MARIA SANTOS NEVES

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL

Trata-se ação obrigacional e indenizatória ajuizada por ROSA MARIA SANTOS NEVES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Narra a autora, beneficiária do plano de saúde réu, que foi diagnosticada com fibrose pulmonar e adenocarcinoma invasivo, sendo indicado por seu médico o uso contínuo do medicamento Pirfenidona (Esbriet) como único tratamento capaz de retardar a evolução da enfermidade e garantir sobrevida. Afirma que o plano negou o fornecimento sob alegação de ausência de cobertura no rol da ANS. Diante disso, requer tutela de urgência para que a ré seja compelida a fornecer imediatamente o medicamento, sem interrupções, bem como indenização por danos morais.

Deferimento da tutela antecipada ao Id. 147441000.

A ré apresentou contestação (Id. 152991096), em que sustenta que o medicamento pleiteado é de uso oral e domiciliar, não previsto no rol da ANS, nem coberto pelo plano, que garante apenas procedimentos médico hospitalares contratados. Argumenta que a ampliação da cobertura sem contraprestação gera desequilíbrio econômico e insegurança jurídica, que a exclusão contratual foi clara e conhecida pela autora. Defende a taxatividade do rol da ANS. Pugna pela improcedência da inicial.

Réplica ao Id. 167705598.

Pedido autoral de alteração do medicamento para nintedanibe (Ofev) ao Id. 172338992.

A autora foi intimada para trazer a negativa do plano de saúdo do fornecimento do novo medicamento (Id. 173969441).

A ré alega que o pedido de alteração de medicamento é extra petita (Id. 175615507).

A autora se manifestou ao Id. 176031662 e juntou documentos ao Id. 182114004.

Foi deferida a mudança do medicamento (Id. 175940044).

Decisão saneadora ao Id. 198077870.

É o relatório. Examinados, decido.

Tratando-se de questão meritória de direito e de fato, e não havendo a necessidade de produção de outras provas, forçoso o julgamento da lide, que pode ser composta no estado que se encontra.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se o autor no conceito de consumidor previsto no artigo 2º da Lei nº 8.078/90, e a operadora de planos de saúde ré no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, §2º, da mesma Lei nº 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise dos autos, não restam dúvidas da necessidade do medicamento. A parte autora comprovou ser portadora de Fibrose Pulmonar e de Adenocarcinoma invasivo, bem como a prescrição médica do medicamento objeto da demanda, conforme documentos acostados à inicial.

Observa-se a alteração do medicamente inicialmente requerido para o medicamento OFEV - Esilato de Nintedanibe (Id. 172338992), classificado como antineoplásico, listado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS para tratamento de câncer de pulmão, e que se encontra registrado na ANVISA.

Conforme consignado na decisão de Id. 175940044, a alteração do medicamento não implica mudança do pedido, “posto que o objeto da presente demanda é o fornecimento da medicação necessária ao tratamento”, o que foi inclusive confirmado em sede de Agravo de Instrumento (Id. 218985500).

O CDC prevê, expressamente, que o contrato deve atender ao fim social para o qual se destina e, no presente caso, o contrato entabulado entre as partes possui finalidade de prestação de serviços médicos e hospitalares, estando incluído o fornecimento dos medicamentos necessários ao pleno estabelecimento do paciente.

É pacífico o entendimento de que os planos de saúde não podem se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois somente o profissional pode definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Nesse ponto, válido destacar a Súmula 211, do Eg. TJRJ: “Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização”.

Logo, importa a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada e não a forma como o tratamento será realizado.

Em relação à alegada taxatividade do rol da ANS, o STJ possui o entendimento de que admite mitigação, tendo sido elencando, como um dos requisitos, justamente a comprovação da eficácia do tratamento à luz da Medicina baseada em evidências.

Ademais, a Lei nº 14.454/2022 restaurou a tese do rol exemplificativo da ANS, estabelecendo, todavia, condicionantes para a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados no referido rol, entre os quais também foi elencado o critério da comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências. Nesse sentido, confira-se a posição da Corte Superior:

> "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
> 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
> 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
> 3. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
> (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
> 4. Em 22/9/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
> 5. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
> 6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".
> (STJ, AREsp n. 2.936.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Esse também é o entendimento do Eg TJRJ:

> “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR COM RISCO DE MORTE, COM INDICAÇÃO MÉDICA PARA USO DO MEDICAMENTO OFEV (NINTEDANIBE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
>
> I.CASO EM EXAME
>
> 1.A parte autora ajuizou ação em face do plano de saúde réu alegando recusa na cobertura do tratamento de fibrose pulmonar. Narra que seu médico receitou o medicamento OFEV (nintedanibe), mas que seu pedido foi negado pelo plano de saúde.
>
> 2.Sentença de procedência parcial determinando o fornecimento do medicamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
>
> 3.Irresignação do plano de saúde réu, pleiteando a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ao argumento de que o medicamento não está previsto contratualmente e não está inserido no rol da ANS.
>
> II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
>
> 4.Cinge-se a controvérsia em analisar a obrigatoriedade no fornecimento do medicamento em questão pelo plano de saúde réu e se há dano moral a ser compensado.
>
> III.RAZÃO DE DECIDIR
>
> 5.Parte autora que comprovou a doença que lhe acometia (Fibrose Pulmonar), bem como a prescrição médica do medicamento objeto da demanda.
>
> 6.Medicamento (OFEV - Esilato de Nintedanibe) classificado como antineoplásico, listado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS para tratamento de câncer de pulmão, e que se encontra registrado na ANVISA.
>
> 7.Apesar de o autor não ter sido acometido por câncer, demonstrou ser portador de doença grave, o que aponta a imprescindibilidade do medicamento para a beneficiária do plano de saúde. Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJRJ que apontam que, em se tratando de doença de especial gravidade, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, não fazendo ressalvas a respeito do medicamento ser ministrado em domicílio ou ambiente ambulatorial/hospitalar.
>
> 8.Direitos à saúde e à vida protegidos constitucionalmente (artigos 6º e 196 DA CRFB). Plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Prescrição médica. Alegação de que o rol da ANS é taxativo. Presença de laudo médico atestando o diagnóstico apontado, bem como a adequabilidade do tratamento prescrito, impossibilidade de a seguradora recorrente impor aos usuários dos serviços contratados limitações de procedimentos necessários ao restabelecimento ou até mesmo à preservação da saúde. abusividade na recusa. aplicação das súmulas 211 e 340, do TJRJ.
>
> 9.Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS que se caracteriza como uma referência básica e, por isso, não é taxativo, conforme determinação da recente lei 14.454/2022. Precedentes do STJ e deste EG. TJRJ no sentido de determinar a cobertura do tratamento em questão pelo plano de saúde. Falha na prestação de serviços que se evidencia.
>
> 10. Dano moral caracterizada e arbitrada em valor aquém dos valores arbitrados em demandas análogas.
>
> 11.Melhor sorte não tem o apelante quanto aos honorários, vez que foram arbitrados em consonância com o disposto no art.85, § 2º do CPC.
>
> IV.DISPOSITIVO.
>
> 12.Recurso conhecido e desprovido (...)”. (TJRJ, 0827920-05.2023.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO - Julgamento: 03/09/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

Torna-se evidente, portanto, o dever do plano de saúde de fornecer o medicamento necessário ao tratamento da autora, motivo pelo qual deve ser confirmada a tutela antecipada concedida.

O dano moral está consubstanciado no descuido da ré na proteção e segurança do consumidor, com a demora para liberação de tratamento destinado à salvaguarda o estado de saúde, que somente obtido por meio do Poder Judiciário, desborda dos meros aborrecimentos cotidianos, implicando em dano à personalidade da consumidora que merece compensação.

Partindo da extensão do dano, considerando que a parte autora necessitou de ingressar com ação para receber o tratamento médico que lhe é necessário, reputo razoável com o viés reparatório e punitivo-pedagógico do instituto a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para: (a) confirmar, em definitivo, a tutela já antecipada; (b) condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a sentença, e acrescidos de juros de mora correspondentes à diferença entre a Selic e o IPCA desde a data da citação.

Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela ré e honorários advocatícios que arbitro 15% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Após, transitado em julgado e sem incidentes, dê-se baixa e arquivem-se.

RIO DE JANEIRO, 24 de setembro de 2025.

VIVIANE TOVAR DE MATTOS ABRAHÃO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: VIVIANE TOVAR DE MATTOS ABRAHÃO
24/09/2025 12:08:09
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25092412080914100000208647632

IMPRIMIR GERAR PDF